

 Osakidetza HUA CCEE HUA CCEE	GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO <i>Deiturak / Apellidos</i> LUIS MARIA <i>Izena / Nombre</i> TOMAS ALFARO, 0013 007 A 1008 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA) <i>Helbidea / Dirección</i>
	CONSULTA EXTERNA
	CONS. CARDIOLOGIA HUA

<i>Historia Zk. / Nº Historia</i>	<i>IKK / CIC</i>	<i>Gizarte Segurantzak Zk. / Nº Seguridad Social</i>	<i>Jaiotze Data / F. Nacimiento</i>
220320	1164816	10015586764	15/05/1956

<i>Zerbitzua / Servicio</i>	<i>Profesional / Profesional</i>
CARDIOLOGIA GRAL.	ESTARAN ALVAREZ, RAFAEL LUIS

MOTIVO DE CONSULTA:

Derivado desde Urgencias por FA.

ANTECEDENTES PERSONALES

- Sin alergia medicamentosa conocida.
- HTA.
- Hiperlipidemia.
- Accidente de bicicleta en el año 2003: TCE grave con fractura de base craneal y fractura temporal izquierda. Hematoma epidural temporal izquierdo. Hematoma subdural temporo-parietal izquierdo. Hemorragia subaracnoidea traumática. Importante desviación de línea media con borramiento de cisternas basales. Preciso tratamiento de rehabilitación por presentar una afasia mixta de predominio motor. Discreta hemiparesia derecha.
- Epilepsia. Última crisis en 2010, generalizada t-c.
- Fístula arteriovenosa dural del seno sigmoide derecho tratada endovascularmente 17 de septiembre de 2018. En control por neuroradiología. Ingresó en junio/19 para control angiográfico con resultado de correcta embolización.
- Antecedentes quirúrgicos: Varices (Dic 2017). Sutura tendón mano 2017 con AG, colonoscopia, evacuación de hematoma subdural y epidural y craniectomía descompresiva por TCE grave en 2003. Fractura humero.
- **Tratamiento habitual (conciliado):**
 ATENOLOL 100MG 1 COMPRIMIDO DESAYUNO
 FELODIPINO 5MG 1 COMPRIMIDO DESAYUNO
 SIMVASTATINA 20MG 1 COMPRIMIDO ACOSTARSE
 LORAZEPAM 1MG 1 COMPRIMIDO ACOSTARSE

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente que consulta por sensación de palpitaciones en el Servicio de Urgencias el día 18/10/19 objetivándose ACXFA, CHADS-VASC 1, revirtiendo con perfusión de vernakalant
 A la semana episodio similar de 45 de duración que cedió espontáneamente por lo que no consultó

EXPLORACIÓN FÍSICA:

TA:125/77 ; FC:63.
 Cabeza y cuello: Carótidas rítmicas . PVC normal.
 Torax: AC: rítmica sin soplos. AP: mvc.
 Abdomen: Blando y depresible sin masas ni megalias.
 EEl: sin edemas, pulsos periféricos presentes y simétricos

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

- ECG: RS a 63 lpm, eje horizontal, BSARIHH

010103397 ESTARAN ALVAREZ, RAFAEL LUIS	FIRMADO:	FECHA INFORME: 14/04/2020
		HORA INFORME: 10:03
		PÁGINA: 1 / 2
		10/2

 Osakidetza HUA CCEE HUA CCEE	GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO <i>Deiturak / Apellidos</i>
	LUIS MARIA <i>Izena / Nombre</i>
	TOMAS ALFARO, 0013 007 A 1008 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA) <i>Helbidea / Dirección</i>
CONSULTA EXTERNA	
CONS. CARDIOLOGIA HUA	

- ECOCARDIOGRAMA:

VI no dilatado ni hipertrófico. FE > 55 %, sin anomalías regionales.

Disfuncion diastolica sin datos de aumento de presiones de llenado.

AI dilatada ligera (38 mL/m2). VM normofuncionante.

VAo trivialva con gradientes discretamente elevados sin insuficiencia aortica . Raiz aortica no dilatada

Cavidades derechas de tamaño y funcion conservada.

IT que no permite estimar PAP. Flujo pulmonar tipo I

VCI no dilatada.

JUICIO DIAGNÓSTICO:

.- Fibrilacion auricular paroxistica CHADS-VASc: 1

.- HTA

.- Hiperlipemia

PLAN:

Por un 1º episodio de fibrilacion no pauto antiarritmicos según la frecuencia valorar tto antiarritmico

En revisión de Abril asintomático sin nuevos episodios de arritmias o taquicardias por nuestra parte no precisa control en CCEE de cardiología .

Impresión Diagnóstica / Diagnóstico: [1]

Fibrilacion auricular

OTRAS RECOMENDACIONES:

En caso de nuevo episodio de FA acudir a urgencias y ante la ausencia de cardiopatía estructural aconsejo utilización de flecainida para valorar eficacia de la misma y posibilidad de estategia Pilling on the pocket

010103397 ESTARAN ALVAREZ, RAFAEL LUIS	FIRMADO:	FECHA INFORME: 14/04/2020
		HORA INFORME: 10:03
		PÁGINA: 2 / 2
		10/2

